https://pje.tjpe.jus.br/1g/img/localizacao/tjpe/brasaoMini.png

Tribunal de Justiça de Pernambuco

Poder Judiciário

Seção A da 21ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810520

Processo nº **0038132-60.2021.8.17.2001**

AUTOR: I. B. L.
REPRESENTANTE: CRISTIANA BRITTON DE MEDEIROS LAMPSON

RÉU: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

SENTENÇA

Vistos etc.

IVISON BRITTON LOPES, menor impúbere, neste ato, representada pela sua genitora, CRISTIANA BRITTON DE MEDEIROS LAMPSON, ambos qualificadas nos autos, através de advogado legalmente habilitado, ingressou com a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, EM CARÁTER ANTECIPADO, em face da AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, também qualificada.

Narra o autor que é beneficiária do plano de saúde da ré, e foi diagnosticada como portador de BAIXA ESTATURA IDEOPATICA (CID 10:E34.3), com altura abaixo da média para idade e gênero, conforme consta no laudo médico emitido pela Dra. Barbara Guiomar Sales Gomes, CRM 130035.

Afirma ainda que o demandante desenvolveu puberdade central, com aumento progressivo de volume testicular, o que acelera a idade óssea e prejudica o prognostico da estatura.

Diante desse quadro foi indicado o tratamento com Leuprorrelina 3,75 mg e Somatropina 12mg de maneira continua e por tempo indeterminado, com a finalidade de promover o bloqueio da puberdade, diminuir o avanço da idade óssea e promover o aumento da estatura.

Aduziu ainda o demandante que a ré negou cobertura ao tratamento em razão de o medicamento solicitado não possuir previsão de cobertura em regime ambulatorial.

Assim, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para compelir o plano de saúde réu para fornecer a medição prescrita, além de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Intimada para se pronunciar sobre o pedido liminar, a demandada não apresentou manifestação (certidão de Id.Num.82644656).

A AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contestação (Id. Num. 83175692), o plano de saúde réu impugnou o valor atribuído à causa, que fosse fixada na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o equivalente ao pedido de indenização por danos morais. No mérito, defende a negativa de cobertura do tratamento através das medicações prescritas, em regime ambulatorial, sob a justificativa de ausência de cobertura segundo o ROL da ANS, que seria taxativo, consoante tese do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, rechaçou a pretensão indenizatória sob o argumento de inexistência de danos morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Réplica sob o Id. Num. 8913819.

Despacho que determinou a manifestação das partes acerca de interesse na produção de novas provas (Id.Num.83581384).

As partes declararam-se satisfeitas em relação ao conjunto probatório produzido, e requereram o julgamento antecipado da lide

O representante do Parquet ofertou parecer, manifestando-se "pela procedência da ação, para que a Seguradora seja compelida a arcar integralmente, com o fornecimento dos medicamentos prescritos, pelo tempo que for necessário, enquanto durar o tratamento, bem como todos os custos deste, conforme indicado no laudo médico, que acompanha o paciente, mediante apresentação de laudo médico atualizado a cada 6 meses à Seguradora". (Id. Num. 115009362).

Vieram-me os autos conclusos.

O feito se apresenta suficientemente instruído e comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC/2015, por não haver necessidade de dilação probatória.

No que tange à **impugnação ao valor da causa**, tem-se que no caso em apreço, a parte autora ingressou com ação sob o procedimento comum, visando a obtenção do custeio/cobertura para fins de fornecimento de medicação cumulada com pedido de indenização por danos morais.

De acordo com o art. 292, VI do CPC/2015, na hipótese de cumulação de pedidos, o valor da causa será equivalente a soma deles. No caso em análise, a parte autora informou na petição inicial (Num. 81570905 - Pág. 12) o valor referente a um ano de tratamento em relação aos dois medicamentos prescritos (**Leuprorrelina**: VALOR UNITÁRIO: R$ 340,00 / VALOR MENSAL: R$ 340,00 / VALOR ANUAL: R$ 4.080,00- **Somatropina**: VALOR UNITÁRIO: R$ 2.734,90/ VALOR MENSAL: R$ 8.202,00/ VALOR ANUAL: R$ 98.424,00).

Em se tratando de tratamento por tempo indeterminado, será considerado o valor anual das prestações (art. 292, §2º CPC/2015). Dessa forma, somando o valor anual do tratamento prescrito (R$ 4.080,00 + R$ 98.424,00) e a pretensão indenizatória (R$ 10.000,00), chega-se ao montante atribuído à causa, qual seja, R$ 112.504,00.

Desse modo, **resta inacolhida a presente impugnação,** mantendo o valor da causa indicado pela parte autora, tendo em vista está em consonância com o art. 292 do CPC/2015.

Ultrapassada a questão prefacial, passo ao exame do mérito.

A controvérsia ora posta cinge-se a determinar se a negativa de cobertura perpetrada pela operadora de plano de saúde demandada foi efetuada de forma ilícita, bem como se houve dano moral decorrente da resistência ao custeio do tratamento de medicamento prescrito para a parte autora.

Cumpre destacar, inicialmente, que os contratos de seguro, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob a ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros. Tal entendimento foi ratificado pelo STJ através do enunciado da Súmula 608: "*aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".*

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

Importa ressaltar que a finalidade precípua do contrato de assistência médica entabulado com a ré é a manutenção da saúde dos contratantes.

Feitas tais considerações, passo a analisar o caso concreto trazido pelas partes.

Consta dos documentos juntados aos autos pela parte demandante o laudo da médica endocrinologista pediátrica, Dra. BÁRBARA GUIOMAR SALES GOMES, CRM 13035, em que aponta a enfermidade que acomete o menor IVISON BRITTON LOPES, qual seja, "*BAIXA ESTATURA IDIOPÁTICA (CID 10: E 34.3). O menor tem estatura atual de 133 cm aos 11 anos e 10 meses de idade, o que representa -2,07 desvios-padrão abaixo da média*

para a idade e gênero. A BAIXA ESTATURA IDIOPÁTICA tem boa resposta com o uso de hormônio de crescimento (Somatropina) segundo evidências científicas nacionais e internacionais, sendo, inclusive, indicado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para este fim. Além disso, o menor desenvolveu puberdade central, está com aumento progressivo de volume testicular, o que acelera e avança a idade óssea, piorando ainda mais o prognóstico estatural. O uso de análogo ao GnRH (hormônio liberador de gonadotrofina- leuprorrelina) em associação à somatropina, promove bloqueio desta puberdade e diminui o avanço da idade óssea, dando mais tempo para a somatropina agir e melhorando o prognóstico estatural do paciente. A medicação deve ser iniciada rapidamente, pois, com o fechamento da cartilagem de crescimento, a criança não tem mais possibilidade de crescer. Caso estas medicações não sejam iniciadas com brevidade, o paciente atingirá estatura adulta abaixo do padrão familiar e populacional, o que pode trazer consequências psicossociais significativas como bullying, queda de rendimento escolar, menor taxa de empregabilidade, isolamento social, entre outros". (Id. Num. 81572653 - Pág. 1)

Como se pode verificar a médica assistente salienta a necessidade urgente do tratamento, tendo em vista o início da puberdade do menor, o avanço da idade óssea e o fechamento da cartilagem, o que significa dizer que se o tratamento não for iniciado com a maior brevidade, será inócuo qualquer meio ou procedimento para sanar a deficiência do hormônio e o demandante não atingirá a estatura média familiar e populacional, o que poderá problemas e transtornos psicológicos desencadeados pela baixa estatura, como ansiedade, depressão, entre outros efeitos maléficos.

Por sua vez, a seguradora negou a cobertura de fornecimento da medicação (Id. Num. 81572662 - Pág. 1), sob o argumento de ausência de o medicamento solicitado não possui previsão de cobertura em regime ambulatorial.

Pois bem. Os medicamentos receitados por médicos para uso domiciliar e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. Isso porque, os planos de saúde, que integram o sistema da Saúde Suplementar, somente são obrigados a custear os fármacos usados durante a internação hospitalar.

As exceções ficam por conta dos antineoplásicos orais para uso domiciliar (e correlacionados), os medicamentos utilizados no *home care* e os remédios relacionados a procedimentos listados no Rol da ANS.

A temática é disciplinada pelo art. 10 da Lei nº 9.656/98, que lista em seus incisos os tratamentos, procedimentos e medicamentos que os planos de saúde não são obrigados a fornecer. O inciso VI do aludido artigo preceitua que, em regra, o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto no art. 12, I, "c" e II, "g" da Lei, *in verbis:*

> *"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *(...)*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*
>
> *Art. 12. (...)*
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> *(...)*
>
> *c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;*
>
> *II - quando incluir internação hospitalar:*
>
> *(...)*
>
> *g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito*

de internação hospitalar;

Em que se pese a previsão legal, havia divergência na Jurisprudência Pátria sobre questão da licitude da negativa de cobertura, pelos planos e seguradoras de saúde, no fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento contido na legislação de regência, consoante arestos que ora colacionados:

> "RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE.
>
> 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).
>
> 2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital.
>
> 3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim.
>
> 4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º, § 1º, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente.
>
> 5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas
>
> 6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença.
>
> (REsp 1883654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021)".

Contudo, de acordo com a nova redação do art.10, §3º da Lei 9.656/1998, dada pela Lei 14.454/2022

"Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14454.htm#art2)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus

nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14454.htm#art2).

No caso em questão, os dois medicamentos prescritos, quais sejam: somatropina e leuprorrelina possuem registro perante a ANVISA sob os números 110130045 e 1004704100019, respectivamente, consoante consulta ao site do órgão regulador[1] (https://d.docs.live.net/8016ed00307af16d/%C3%81rea%20de%20Trabalho/21%20VARA%20C%C3%8DVEL%20A/SENTEN%
60.2021.8.17.2001%20senten%C3%A7a%20-%20plano%20de%20sa%C3%BAde%20-
%20negativa.%20medicamento.%20horm%C3%B4nio%20do%20crescimento.%20%20fora%20rol%20ans.%20danos%20m

Muito embora não integram o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória, nos moldes da Resolução Normativa- RN Nº 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021, existe recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), através do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Deficiência de Hormônio do Crescimento – Hipopituitarismo (Relatório de Recomendação nº 351 de março de 2018) do tratamento através do fármaco SOMATROPINA.

Em crianças e adolescentes é indicado o uso da SOMATROPINA 0,025-0,035 mg/kg/dia ou 0,075-0,10 UI/kg/dia, administrada por via subcutânea, à noite, 6-7 vezes/semana, ajustada conforme peso corporal, velocidade de crescimento e níveis de IGF-1 (12).

No caso dos autos, foi indicado ao autor 0,05 mg/kg/dia, o que está em plena consonância com a recomendação.

O uso associado do medicamento leuprorrelina não poderá ser excluído, sob pena de comprometimento do uso da somatropina e ineficácia do tratamento, pois, conforme relatório médico, o demandante está com aumento progressivo de volume testicular causado pela puberdade, pois conta hoje com 13 anos e 4 meses, o que acelera a idade óssea e interfere a eficácia da somatropina. Dessa forma, o uso da leuprorrelina tem como finalidade bloquear os efeitos da puberdade, retardando a idade óssea de modo a possibilitar a ação da somatropina no organismo do paciente, garantindo o crescimento esperado.

Nesse sentido vem se inclinando a Jurisprudência Pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AUTORA MENOR IMPÚBERE DIAGNOSTICADA COM HIPOPITUITARISMO. NECESSIDADE DE SUPRIR DEFICIÊNCIA DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (GH) NO ORGANISMO. MEDICAMENTO CONTENDO PRINCÍPIO ATIVO SOMATROPINA QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NA ANVISA. RECUSA EM AUTORIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS SÚMULA Nº 343, 339 E 340 DO TJRJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AUTORA MENOR IMPÚBERE DIAGNOSTICADA COM HIPOPITUITARISMO. NECESSIDADE DE SUPRIR DEFICIÊNCIA DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (GH) NO ORGANISMO. MEDICAMENTO CONTENDO PRINCÍPIO ATIVO SOMATROPINA QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NA ANVISA. RECUSA EM AUTORIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS SÚMULA Nº 343, 339 E 340 DO TJRJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AUTORA MENOR IMPÚBERE DIAGNOSTICADA COM HIPOPITUITARISMO. NECESSIDADE DE SUPRIR DEFICIÊNCIA DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (GH) NO ORGANISMO. MEDICAMENTO CONTENDO PRINCÍPIO ATIVO SOMATROPINA QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NA ANVISA. RECUSA EM AUTORIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS SÚMULA Nº 343, 339 E 340 DO TJRJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.. AUTORA MENOR IMPÚBERE DIAGNOSTICADA COM HIPOPITUITARISMO. NECESSIDADE DE SUPRIR DEFICIÊNCIA DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (GH) NO ORGANISMO. MEDICAMENTO CONTENDO PRINCÍPIO ATIVO SOMATROPINA QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NA ANVISA. RECUSA EM AUTORIZAR O

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS SÚMULA Nº 343, 339 E 340 DO TJRJ. **Contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares que abrange a possibilidade de tratamento endocrinológico, não havendo razão que justifique a negativa da utilização do medicamento aqui pleiteado, o qual assegura maior eficiência e possibilidade de melhora na saúde do paciente.** Inteligência da Súmula 340 deste TJRJ. Rol de Procedimento da ANS, vigente desde 2018, que prevê tratamento com hormônio do crescimento. Medicamento contendo princípio ativo somatropina que se encontra atualmente registrado na ANVISA. Obrigação do plano de fornecer um dos medicamentos que esteja registrado na ANVISA, dentre aqueles que contenham a substância somatropina. Firmou-se o entendimento neste Tribunal de Justiça, através da Súmula 339 de que "A recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral." Destarte, deve ser mantida a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada pelo julgador de primeiro grau. Súmula 343 do TJRJ. Recurso não provido com base no artigo 932, inciso IV, alínea a, do CPC. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação. (TJ-RJ - APL: 01113338520198190001, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 13/05/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ENDOCRINOLÓGICO. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO**. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a custear o medicamento Somatropina, da seguinte forma: (a) fornecimento direto e mensal do medicamento, cabendo a ela a compra e o custeio ou (b) disponibilização mensal do valor do medicamento, tão logo apresentado o orçamento pelos autores; seja o plano condenado a restituir em dobro todos os valores dispendidos na compra do medicamento Somatropina pelos genitores da menor; a condenação, ainda, do plano de saúde em danos morais no valor de R$ 5.000,00 a serem pagos a cada um dos requerentes. 2. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 2.1. Em consequência, firmou-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. 2.2. É certo que o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. 3. **Convém consignar que a assistência à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos da Lei 9.656/98 e do contrato firmado entre as partes (art. 35-F da Lei 9.656/98). 4. Ainda, a ré, ao se recusar a custear o tratamento do autor, infringiu os termos do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.** Por conseguinte, a negativa do custeio do tratamento constitui prática abusiva e nula a cláusula contratual que a respaldou. 5. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 07202908820218070001 1627993, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 19/10/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/10/2022).

Portanto, revela-se injusta a negativa de cobertura perpetrada pelo plano de saúde, prosperando tanto o pleito alusivo à obrigação de fazer da demandada de custear o tratamento indicado pelo médico assistente da parte autora.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este também é procedente. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou recente entendimento no sentido de que a violação a direitos da personalidade, a exemplo dos direitos à saúde e à vida, caracteriza, por si só, o dano moral, não sendo necessária sequer a ocorrência de reação psíquica da vítima, como os sentimentos de dor, vexame, sofrimento, etc[2]
(https://d.docs.live.net/8016ed00307af16d/%C3%81rea%20de%20Trabalho/21%20VARA%20C%C3%8DVEL%20A/SENTEN%

60.2021.8.17.2001%20senten%C3%A7a%20-%20plano%20de%20sa%C3%BAde%20-%20negativa.%20medicamento.%20horm%C3%B4nio%20do%20crescimento.%20%20fora%20rol%20ans.%20danos%20m [1].

A conduta da ré ultrapassou o mero descumprimento de dever contratual, na medida em que, ao recusar a realização de procedimentos indicados por médicos conveniados, inviabilizou o pleno exercício do direito à saúde do consumidor, lesando sua dignidade, restando caracterizado o dano de natureza extrapatrimonial

Assim, o dano moral resta configurado, por ter a empresa demandada agido em desrespeito aos mais preciosos bens de um indivíduo, que são sua vida, saúde e dignidade. O entendimento é esposado pelo STJ, a exemplo do seguinte julgado:

STJ-0451560 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COBERTURA FINANCEIRA DE TRATAMENTO MÉDICO) E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes. 2. O óbice insculpido na Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com amparo na alínea "c" do permissivo constitucional, sendo também aplicável aos reclamos fundados na alínea "a", uma vez que a expressão "divergência", referida no citado verbete sumular, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional. 3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 430.208/CE (2013/0376246-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 20.03.2014, unânime, DJe 09.04.2014).

Suficientemente demonstrado o dano de índole moral, resta fixar o valor da indenização devida, o que faço levando em consideração a gravidade do fato em si e a extensão do dano sofrido, nos termos do art. 944 do Código Civil, razão por que arbitro a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Esclareço que, nos termos do art. 292, inciso V, do CPC/15, a parte autora deve quantificar sua pretensão indenizatória a título de danos morais, que deve ser considerada para o arbitramento do valor da causa.

Apesar da necessidade de estipulação da quantia almejada, continua válido o enunciado da Súmula nº 326, do STJ, o qual estabelece que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Isso porque o bem da vida pretendido pela parte, na hipótese, é o reconhecimento do dano suportado em decorrência de ato ilícito praticado pela parte adversa e o recebimento da respectiva indenização.

O arbitramento do *quantum* indenizatório compete exclusivamente ao julgador, diante da análise dos elementos do caso concreto, não podendo o juiz ficar restrito à quantia indicada pela parte na petição inicial, na medida em que a extensão do dano apenas pode ser apurada em cotejo ao acervo probatório constante dos autos. Assim, o acolhimento do pleito indenizatório configura integral procedência do pedido, ainda que o valor estipulado seja inferior ou superior ao indicado pela parte autora na inicial.

a) JULGO PROCEDENTE o pedido de condenação da ré na obrigação de fazer, e estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, **concedo a tutela provisória de urgência** pleiteada para determinar à ré, independente do trânsito em julgado, autorize, e custeie integralmente as despesas relacionadas ao tratamento da autora, notadamente o fornecimento dos medicamentos SOMATROPINA e LEUPRORRELINA, pelo período, forma e na dosagem que se fizer necessária, tudo conforme laudo médico de Id. Num. 81572653, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da ciência da decisão, sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$ 1.0000,00 (um mil reais), limitada 30 (trinta) dias.

b) JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta a ser corrigida monetariamente pela tabela ENCOGE, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tudo até o efetivo pagamento.

Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, verificada a inércia da parte interessada, arquivem-se independentemente de nova conclusão.

Intime-se a parte demandada por mandado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recife, 03 de novembro de 2022.

Nehemias de Moura Tenório

Juiz de Direito

---

[1] (https://d.docs.live.net/8016ed00307af16d/%C3%81rea%20de%20Trabalho/21%20VARA%20C%C3%8DVEL%20A/S
60.2021.8.17.2001%20senten%C3%A7a%20-%20plano%20de%20sa%C3%BAde%20-
%20negativa.%20medicamento.%20horm%C3%B4nio%20do%20crescimento.%20%20fora%20rol%20ans.%20dar
https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaId=110130045 (https://www.smerp.com.br/anvisa/?
ac=prodDetail&anvisaId=110130045); https://www.smerp.com.br/anvisa/?
ac=prodDetail&anvisaId=1004704100019 (https://www.smerp.com.br/anvisa/?
ac=prodDetail&anvisaId=1004704100019)

(https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaId=1004704100019)[2]
(https://d.docs.live.net/8016ed00307af16d/%C3%81rea%20de%20Trabalho/21%20VARA%20C%C3%8DVEL%20A/S
60.2021.8.17.2001%20senten%C3%A7a%20-%20plano%20de%20sa%C3%BAde%20-
%20negativa.%20medicamento.%20horm%C3%B4nio%20do%20crescimento.%20%20fora%20rol%20ans.%20dar

[1] STJ, 4ª Turma, REsp 1.245.550-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/3/2015.

Assinado eletronicamente por: **NEHEMIAS DE MOURA TENORIO**
07/11/2022 11:52:59
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **118772896**

22110711525951600000116097108

IMPRIMIR GERAR PDF